

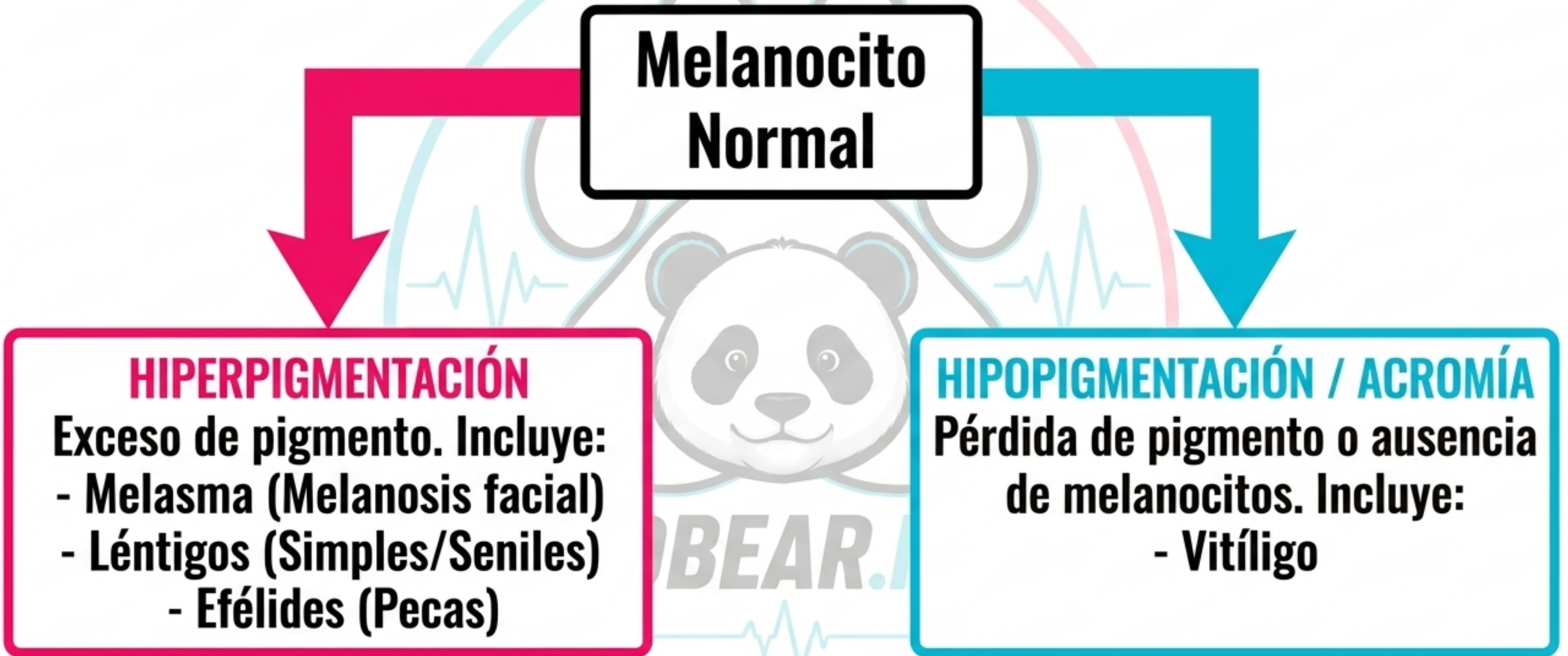


Trastornos Pigmentarios de la Piel (Discromías)

Guía Maestra de Estudio y Diagnóstico Clínico



El Espectro de las Discromías



Melasma (Melanosis Facial): Perfil Clínico y Etiología



Hiperpigmentación macular adquirida (marrón claro a oscuro). Distribución simétrica y bordes irregulares.

Etiología: Hormonal (Embarazo 'máscara del embarazo', anticonceptivos), Genética, Radiación Solar (exacerba el cuadro), Fármacos fototóxicos y cosméticos.

Perla Clínica: El examen con Lámpara de Wood acentúa las máculas hiperpigmentadas epidérmicas. Diagnóstico diferencial principal: Hiperpigmentación postinflamatoria.



Escalón Terapéutico del Melasma

Paso 1: Prevención y Bloqueo.
Identificar causa (suspender fármacos). Uso estricto de bloqueadores solares (FPS 30-50, óxido de zinc).

Paso 2: Terapia Tópica Despigmentante.
Fórmulas magistrales combinadas.
Opciones: Hidroquinona (3-7%), Ácido Kójico (2-5%), Ácido Fítico (2-4%), Ácido Glicólico (2-10%), Ácido Mandélico (5-10%), Tretinoína, Arbutín.
Uso nocturno.

Paso 3: Procedimientos Físicos y Químicos.
Peeling Químico (Ácido Glicólico 20%, Mandélico 15%, TCA 10-20%) para exfoliación profunda.
Terapia con Láser (destrucción selectiva de pigmento).



Léntigos: Máculas Pigmentadas Benignas

Definición: Máculas pigmentadas en forma de lenteja, ovaladas.

Léntigo Simple (Juvenil)



- **Inicio:** Infancia/Adolescencia.
- **Tamaño:** <5mm.
- **UV:** No relacionada con luz solar.
- **Color:** Marrón claro a negro.

Léntigo Senil



- **Inicio:** >50 años (Fototipos I-III).
- **Tamaño:** 3-12mm (pueden confluir).
- **UV:** Altamente relacionada con exposición solar aguda/crónica.
- **Ubicación:** Zonas fotoexpuestas (dorso de manos, cara, cuello).



Lentiginosis: Manifestaciones Sistémicas

Definición: Abundante presencia de múltiples léntigos.

Histología: Hiperplasia de la epidermis y aumento de melanocitos en la capa basal sin atipia.



Síndrome de Peutz-Jeghers:

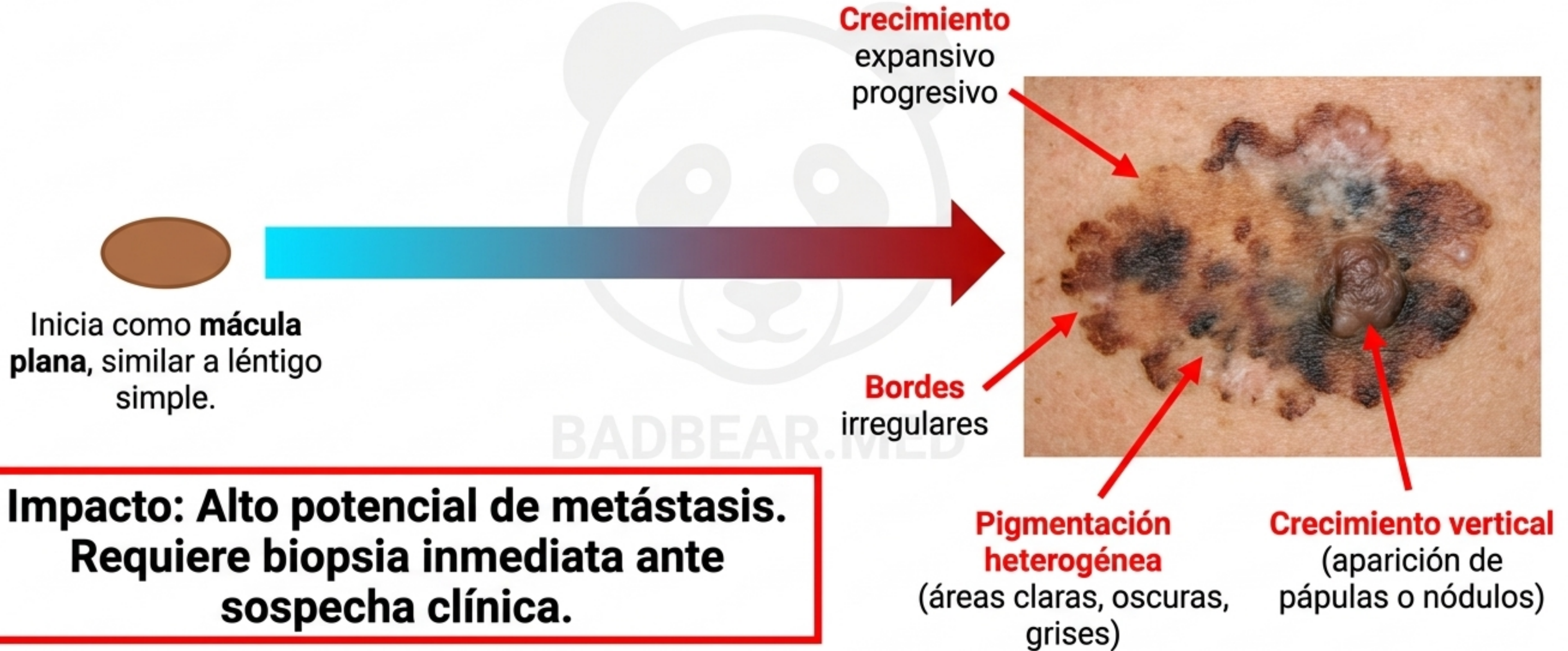
- Autosómico dominante.
- Lentiginosis periorifical (labios, mucosa oral).
- Asociada a pólipos hamartomatosos gastrointestinales (bajo riesgo de malignización).

Síndrome de LEOPARD:

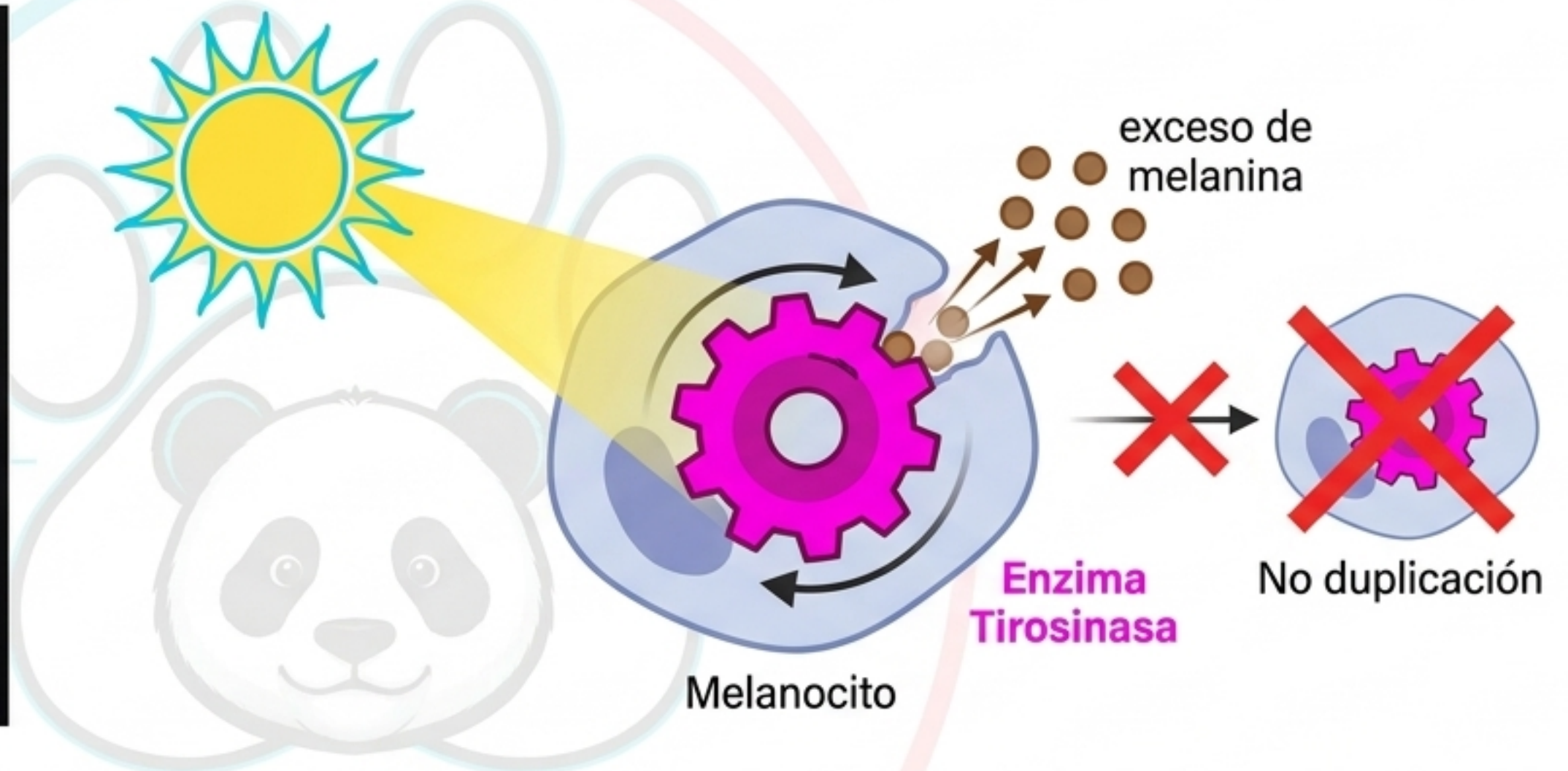
- L** → éntigos múltiples +
- E** → Electrocardiograma anormal
- O** → Ocular hipertelorismo
- P** → Pulmonar estenosis
- A** → Anormalidades genitales
- R** → Retraso del crecimiento
- D** → Sordera (Deafness)



Alerta Clínica: Léntigo Melanoma Maligno



Efélides (Pecas): Genética y Fisiopatología



Definición:

Máculas pequeñas (2-4mm), bordes netos, color pardusco, en zonas fotoexpuestas. Predomina en fototipos I-III, pelirrojos/rubios.

Fisiopatología Clave:

No hay aumento de melanocitos. Existe una mayor actividad de la enzima tirosinasa en melanocitos existentes, produciendo un exceso de melanina tras la exposición UV.
Genética: Variante del gen MC1R (Autosómica dominante).

Diagnóstico Diferencial Clave:

Signo de Crowe (Efélides axilares/inguinales que aparecen en la pubertad).



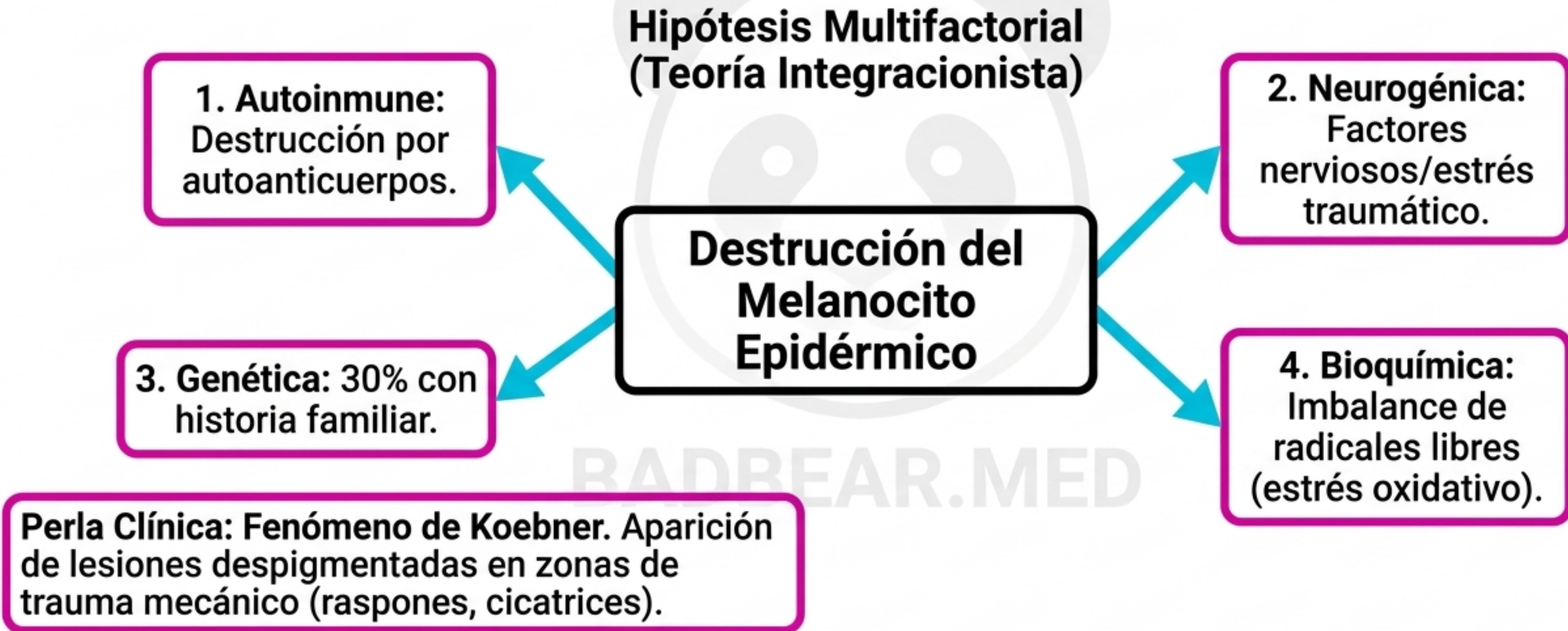
Modalidades Físicas para Hiperpigmentación (Léntigos y Efélides)

 Criocirugía (Nitrógeno Líquido)	 Terapia Láser	 Peeling Químico Agresivo
Destrucción por congelamiento. Riesgos: Eritema intenso, costras, cicatrización hipertrófica/queloide, hipopigmentación residual.	De elección por ser segura y selectiva. Destruye selectivamente el pigmento acumulado sin dañar tejidos circundantes.	Ácido Tricloroacético (TCA) al 15-20%, Ácido Salicílico al 50%. Produce quemadura controlada y recambio epidérmico a los 7-10 días.

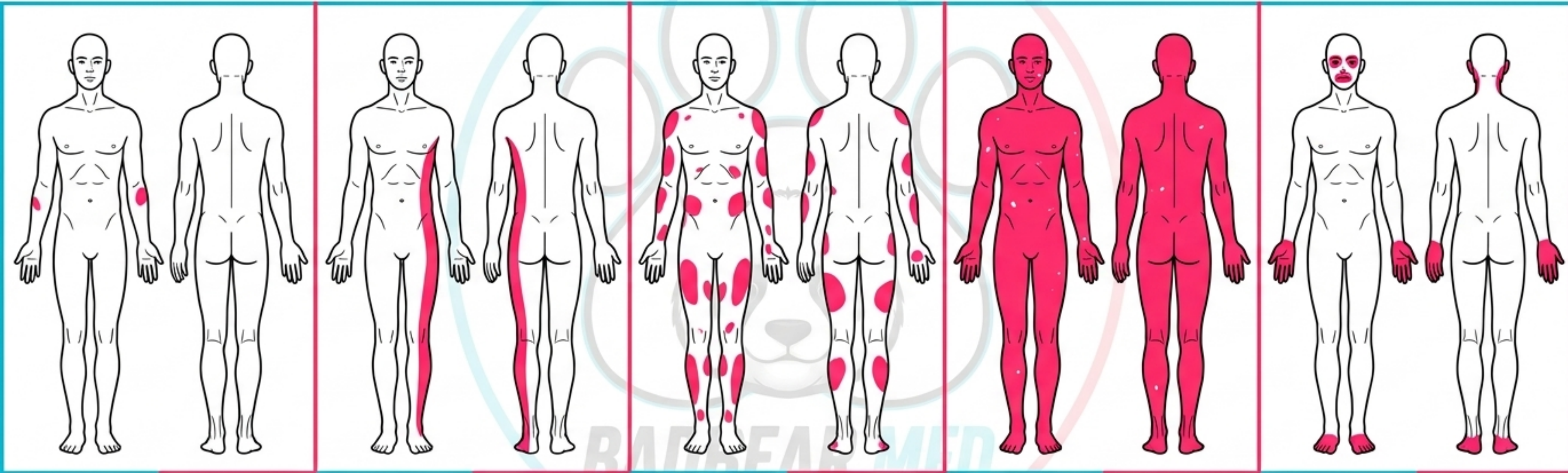


Vitíligo: El Enigma Etiológico y Fisiopatológico

Pérdida adquirida de pigmentación caracterizada por la ausencia histológica de melanocitos epidérmicos (máculas hipocrómicas o acrómicas).



Clasificación Toppoográfica del Vitíligo



Focalizado:
Lesiones aisladas en un solo sitio anatómico.

Segmentario:
Sigue el trayecto de una metámera/dermatoma (unilateral, en banda).

Generalizado:
Distribución amplia y estrictamente simétrica.

Universal:
Despigmentación casi total del cuerpo.

Acrofacial:
Compromiso exclusivo de extremos distales y zona facial/periorificial.



Asociaciones Sistémicas (El Vitíligo no viene solo)

Es mandatorio buscar comorbilidades sistémicas, particularmente de origen autoinmune o endocrino.



Tiroides:
Hipotiroidismo e
Hipertiroidismo.



Páncreas:
Diabetes Mellitus.



Hematología:
Anemia Perniciosa,
Linfoma, Leucemia.



Infeccioso: VIH.



Vitíligo: Manejo Médico y Fototerapia

Terapias Tópicas

Opciones: Corticosteroides, 5-Fluorouracilo, Inmunomoduladores, Melagenina (derivado placentario), Pseudocatalasa.

PUVA

Uso oral/tópico de Psoralenos (fotosensibilizantes) seguido de exposición a luz UVA por ~5 minutos.

Fototerapia (UVB Banda Angosta - NBUVB): Terapia de elección moderna.

Luz UV (Banda Angosta)

1. Detiene la destrucción activa de melanocitos.

2. Incrementa el número de melanocitos residuales para restaurar la pigmentación.



Tratamiento Quirúrgico del Vitíligo Refractario

Indicación: Pacientes con vitíligo estable que no responden a tratamiento médico/luz. Otras opciones incluyen injertos epidérmicos/dermoepidérmicos y trasplante de melanocitos cultivados.

Mini Injertos Autólogos (Punch Grafts)



1. Extracción: Uso de un sacabocados (punch de 2-3mm) para extraer tejido de una zona donante pigmentada activa.



2. Implantación: Se realizan orificios del mismo tamaño en la mácula acrómica y se siembra el tejido.



3. Repigmentación: El injerto estimula el crecimiento y migración de melanocitos hacia la piel despigmentada circundante.



Matriz Maestra de Diagnóstico Diferencial (Discromías)

Patología	Fisiopatología	Relación UV	Topografía Típica	Tratamiento Primera Línea
Melasma	↑ Producción de pigmento	Exacerba el cuadro	Facial simétrico y antebrazos	Despigmentantes tópicos y fotoprotección
Léntigo Simple	↑ Melanocitos basales	Ninguna relación	Cualquier zona expuesta o no	Láser o crioterapia
Léntigo Senil	↑ Melanocitos basales	Causal directo (>50 años)	Zonas fotoexpuestas crónicas	Láser o crioterapia
Efélides (Pecas)	↑ Actividad de Tirosinasa	Disparador directo	Cara, hombros, escote	Fotoprotección estricta
Vitíligo	Ausencia de melanocitos	No aplica (Koebner sí)	5 patrones (Acrofacial, etc.)	Esteroides tópicos / NBUVB

